

Czym jest *atak paniki*?

Nagły lęk z objawami fizycznymi. Szczyt w 10 min, koniec w 20–30 min. Bardzo nieprzyjemny, kompletnie bezpieczny.

CZAS: 10 min czytania Pierwszy krok terapii **ŹRÓDŁO:** Clark (1986); Barlow (2002); NICE CG113 (2011)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj raz uważnie, drugi raz z ołówkiem — podkreśl fakty, które najbardziej Cię zaskoczyły. Wróć po pierwszym ataku po terapii i sprawdź, które fakty pomogły. **Cel:** przesunąć interpretację z „dzieje się coś strasznego” na „nieprzyjemne, ale niegroźne”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Według modelu Clarka (1986) to **nie samo odczucie** (kołatanie, duszność) wywołuje pełny atak — wywołuje go *katastroficzna interpretacja* tego odczucia. Sama psychoedukacja redukuje liczbę ataków o **20-40%** — dlatego NICE CG113 rekomenduje ją jako 1. krok przed jakimkolwiek innymi technikami.

01 Co dzieje się w ciele podczas ataku

Atak paniki to **fałszywy alarm** układu walcz/uciekaj (ang. *fight-or-flight*). Twoje ciało reaguje tak, jakby przed Tobą stało zagrożenie życia — ale samego zagrożenia nie ma. Wszystko, co czujesz, jest *celowym, ochronnym mechanizmem* przygotowującym Cię do ucieczki, która nie jest potrzebna.

KOŁATANIE · DUSZNOŚĆ

Co czujesz: serce wali, brakuje powietrza.
Co naprawdę robi ciało: adrenalina przyspiesza krążenie i oddech, by dostarczyć tlen do mięśni.
Tlenu jest za dużo, nie za mało.

ZAWROTY · MROWIENIE

Co czujesz: kręci Ci się w głowie, mrowią ręce i twarz.
Co naprawdę robi ciało: szybki oddech wydychuje CO₂ — to *hiperwentylacja*, która zwęża naczynia w mózgu. Niegroźne.

UCISK W KLATCE

Co czujesz: ciężar lub ból w klatce.
Co naprawdę robi ciało: napięte mięśnie międzyżebrowe (gotowość do walki). Po EKG bez zmian — to mięśnie, nie serce.

NIEREALNOŚĆ · ODDZIELENIE

Co czujesz: „nie jestem tu”, „świat jest dziwny”.
Co naprawdę robi ciało: mózg skupia uwagę na zagrożeniu kosztem peryferii. Hiperwentylacja nasila ten efekt. *Nie tracisz rozumu.*

02 Siedem faktów, które obalają katastrofę

1. Kołatanie ≠ zawał. Serce jest zdrowe — adrenalina je przyspiesza. Limit fizjologiczny ok. 160–180 uderzeń/min.

3. Zawroty ≠ omdlenie. W panice ciśnienie krwi *rośnie*. Do omdlenia potrzebny spadek ciśnienia — odwrotny mechanizm.

5. „Nierealność” ≠ szaleństwo. To skutek hiperwentylacji. Mija wraz z odzyskaniem normalnego oddechu.

7. Atak nigdy nie był i nie będzie śmiertelny. W historii medycyny nie ma udokumentowanego zgonu z powodu samego ataku paniki. Ciało *chroni*, nie atakuje.

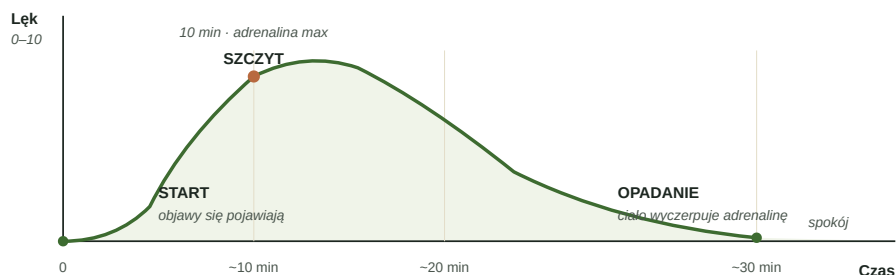
2. Duszność ≠ uduszenie. Hiperwentylacja daje za *dużo* tlenu, nie za mało. Mózg odczytuje to jako brak powietrza.

4. Mrowienie ≠ udar. Spadek CO₂ we krwi zmienia poziom wapnia zjonizowanego. Sygnał chemiczny, nie neurologiczny.

6. Atak trwa maks. 20-30 min. Adrenalina ma wbudowany limit. Ciało nie utrzyma ataku dłużej, nawet gdybyś chciał/-a.

03 ⌚ Przebieg ataku w czasie

Atak ma stały, przewidywalny kształt: szybkie narastanie, krótki szczyt, opadanie. Niezależnie od tego, co zrobisz, krzywa zawsze wraca w dół — bo adrenalina się wyczerpuje.



Klucz: nie musisz nic robić, by atak się skończył. Skończy się sam. Twoje zachowanie wpływa tylko na to, czy *nauczysz się*, że jesteś bezpieczny/-a — czy nadal będziesz się go bać.

04 ✗ Trzy pułapki, które przedłużają problem

UNIKANIE MIEJSC

„Nie pojadę metrem, bo tam mam ataki.” Każde uniknięcie potwierdza mózgowi: *było zagrożenie*. Lęk rośnie, świat się kurczy.

ZACHOWANIA ZABEZPIECZAJĄCE

Butelka wody, leki w kieszeni, telefon w ręku „na wszelki wypadek”. *To one* trzymają lęk — bo mózg myśli, że to one Cię uratowały.

SPRAWDZANIE CIAŁA

Liczenie tętna, mierzenie ciśnienia, googlowanie objawów. Im więcej skanujesz, tym więcej znajdziesz — *uwaga skierowana do wewnątrz* napędza objawy.

Klucz: psychoedukacja sama redukuje ataki o 20–40% (NICE CG113). To podstawa, ale nie wystarczy — pełne wygaszenie wymaga przećwiczenia nowej interpretacji w *dekatastrofizacji* i *ekspozycji interoceptywnej* (ang. *interoceptive exposure*). Wracaj do tego arkusza po każdym ataku — w pierwszych tygodniach najczęściej zapomina się, że atak **NA PEWNO** się skończy.

05 ✎ Mój osobisty fakt do zapamiętania

Wybierz jeden fakt z całej karty, który *najbardziej* Cię zaskoczył lub uspokoił. Zapisz własnymi słowami — tak, jakbyś tłumaczył/-a to przyjacielowi.